



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN KERJA TIM REVIEW REKAM MEDIS

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan
Telp. 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pedoman Kerja Tim Review Rekam Medis ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini merupakan acuan resmi dalam pelaksanaan evaluasi kualitas, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keterbacaan berkas rekam medis secara objektif, sistematis, dan bertanggung jawab di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Pembentukan dan penguatan Tim Review Rekam Medis sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka menjaga akurasi data klinis, meningkatkan mutu pelayanan, serta menjamin keselamatan pasien. Pengelolaan rekam medis yang bermutu merupakan pilar penting dalam tata kelola klinis yang baik dan memerlukan komitmen bersama serta pendekatan multidisiplin dari seluruh Profesional Pemberi Asuhan (PPA). Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai panduan operasional bagi seluruh anggota tim dan pihak terkait dalam menjalankan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya secara terstruktur dan terkoordinasi.

Pedoman ini mengacu pada berbagai regulasi dan standar nasional, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis serta Standar Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan penjaminan mutu rekam medis, baik elektronik maupun non-elektronik, dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkesinambungan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan mutu pendokumentasian asuhan pasien, mendukung keselamatan pasien, serta memastikan kepatuhan rumah sakit terhadap regulasi kesehatan yang berlaku.

Akhir kata, kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi informasi kesehatan dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Pasuruan, 17 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Kerja Tim Review Rekam Medis
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2025

Disusun oleh :
Ketua Tim Review Rekam Medis



(dr. Tamara Aulia Fakhriinnisa)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.)

TIM PENYUSUN**PENGARAH**

- 1) Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP
- 2) dr. Tamara Aulia Fakhriinnisa
- 3) Fina Fitriana D.N.H. , Amd. RMIK

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2. Tujuan.....	10
1.3 Sasaran.....	11
BAB II.....	12
KEBIJAKAN	12
BAB III.....	13
PENGORGANISASIAN.....	13
3.1 Struktur Organisasi	13
3.2 Persyaratan Jabatan, Uraian Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang sebagai berikut:	13
BAB IV	17
SARANA DAN FASILITAS.....	17
4.1 Sarana	17
4.2 Dukungan Manajemen.....	17
BAB V	18
TATA LAKSANA.....	18
BAB VI	19
PENCATATAN DAN PELAPORAN.....	19
6.1 Pencatatan dan pelaporan	19
BAB VII.....	20
MONITORING DAN EVALUASI	20
7.1. Monitoring.....	20
7.2. Evaluasi	20

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR 1155/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025

TENTANG

PEDOMAN KERJA TIM REVIEW REKAM MEDIS

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO,

- Menimbang : 1) bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi dari setiap instalasi pelayanan yang ada;
- 2) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Kerja Tim Review Rekam Medis.
- Mengingat : 1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
- 8) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 Tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik;
- 9) Kepdirjen Nomor HK.01.07./MENKES/1596/.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
- 10) Kepdirjen Nomor Hk.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman survei Akreditasi Rumah Sakit;
- 11) Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur RS Prima Husada Sukorejo;
- 12) Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN KERJA TIM REVIEW REKAM MEDIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Tim review rekam medis adalah sekelompok orang yang mereview dokumen rekam medis yang telah diisi oleh Professional Pemberi Asuhan (PPA)
- 2) Review dokumen rekam medis adalah penilaian berkas rekam medis yang dikembalikan dari ruang perawatan ke unit rekam medis apakah sudah diisi dengan lengkap, jelas dan benar oleh dokter, perawatan dan tenaga kesehatan lainnya
- 3) Staf klinis adalah semua tenaga klinis atau kesehatan yang memberikan asuhan kesehatan kepada pasien.
- 4) Staf non klinis adalah staf yang tidak memberikan asuhan kepada pasien

BAB II PEMBENTUKAN TIM REVIEW REKAM MEDIS

Pasal 2

1. Rumah sakit menetapkan individu atau tim yang melakukan review rekam medis secara berkala
2. Review rekam medis menggunakan sampel yang mewakili
3. Proses review termasuk isi rekam medis harus esuai dengan peraturan dan perundang-undangan
4. Proses review termasuk rekam medis pasien yang masih dirawat dan pasien yang sudah pulang
5. Hasil review dilaporkan secara berkala kepada direktur rumah sakit

BAB III KEGIATAN TIM REVIEW REKAM MEDIS

Pasal 3

Fokus review rekam medis adalah ketepatan waktu, keterbacaan, dan kelengkapan rekam medis

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pedoman kerja tim review rekam medis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan direktur ini
- 2) Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 17 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA SUKOREJO
NOMOR 1155/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025
TENTANG
PEDOMAN KERJA
TIM REVIEW REKAM MEDIS

PEDOMAN KERJA TIM REVIEW REKAM MEDIS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menghadapi era pasar global, persaingan industri pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit bergerak dengan sangat dinamis dan kompetitif. Rumah sakit tidak lagi sekadar menjadi lembaga sosial, melainkan institusi sosio-ekonomi yang dituntut mengelola layanannya secara profesional. Oleh karena itu, rumah sakit harus mampu mengubah paradigma lama yang bersifat konvensional dan administratif menjadi pelayanan yang modern berbasis mutu dan keselamatan pasien (*patient safety*).

Upaya memenuhi tuntutan terhadap pelayanan modern ini mengharuskan Rumah Sakit Prima Husada sebagai penyedia pelayanan kesehatan untuk selalu berupaya meningkatkan mutu layanannya secara berkesinambungan (*Continuous Quality Improvement*). Mutu pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan kondisi, budaya kerja, dan nilai-nilai yang dianut baik oleh rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan maupun pasien sebagai penerima jasa layanan.

Sektor fundamental yang menjadi cerminan mutu pelayanan medis di rumah sakit adalah tata kelola rekam medis. Rekam medis yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan bermutu mencerminkan praktik kedokteran yang baik (*good medical practice*), sekaligus menjadi alat bukti hukum yang sah untuk melindungi hak pasien maupun tenaga kesehatan. Sebaliknya, rekam medis yang buruk mencerminkan asuhan pasien yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Sebagai rumah sakit yang terus berkembang, Rumah Sakit Prima Husada membentuk Tim Review Rekam Medis. Pedoman Kerja Tim Review Rekam Medis ini disusun sebagai komitmen manajemen untuk melaksanakan kebijakan review, evaluasi, dan monitoring rekam medis dalam ruang lingkup yang komprehensif demi tercapainya standar mutu tertinggi.

Tim Review Rekam Medis memiliki tugas utama diantaranya sebagai berikut :

1. Mengurangi Angka Ketidaklengkapan Pengisian Dokumen Rekam Medis (KPCM): Mengidentifikasi, mengukur, dan menekan persentase berkas rekam medis yang tidak diisi lengkap oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA).
2. Meningkatkan Angka Keterbacaan Dokumen Rekam Medis: Memastikan setiap coretan tangan, instruksi medis, dan catatan klinis pada rekam medis manual terbaca dengan jelas, serta mendorong implementasi validasi data input pada Rekam Medis Elektronik (RME) demi mencegah kesalahan medis (*medical error*).
3. Meningkatkan Angka Ketepatan Waktu Pengisian: Memastikan kepatuhan PPA dalam menyelesaikan rekam medis (terutama ringkasan pulang/discharge summary) dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam setelah pasien keluar.

1.2. Tujuan

1. Tujuan Umum

Sebagai acuan baku dan panduan operasional bagi Tim Review Rekam Medis dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan review rekam medis guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Prima

Husada.

b) Tujuan Khusus

- a. Menjamin kualitas dan keandalan data rekam medis secara berkelanjutan (*kualitatif dan kuantitatif*).
- b. Meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan kedisiplinan seluruh staf klinis/PPA akan pentingnya rekam medis yang baik.
- c. Terpenuhinya standar tata kelola rekam medis yang sesuai dengan regulasi nasional dan instrumen akreditasi rumah sakit.
- d. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan pelatihan berkala kepada manajemen terkait temuan ketidakpatuhan pengisian rekam medis.

1.3 Sasaran

- 1) Internal (Profesional Pemberi Asuhan/PPA): Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit Prima Husada.
- 2) Eksternal : Pelaporan institusi terkait

BAB II

KEBIJAKAN

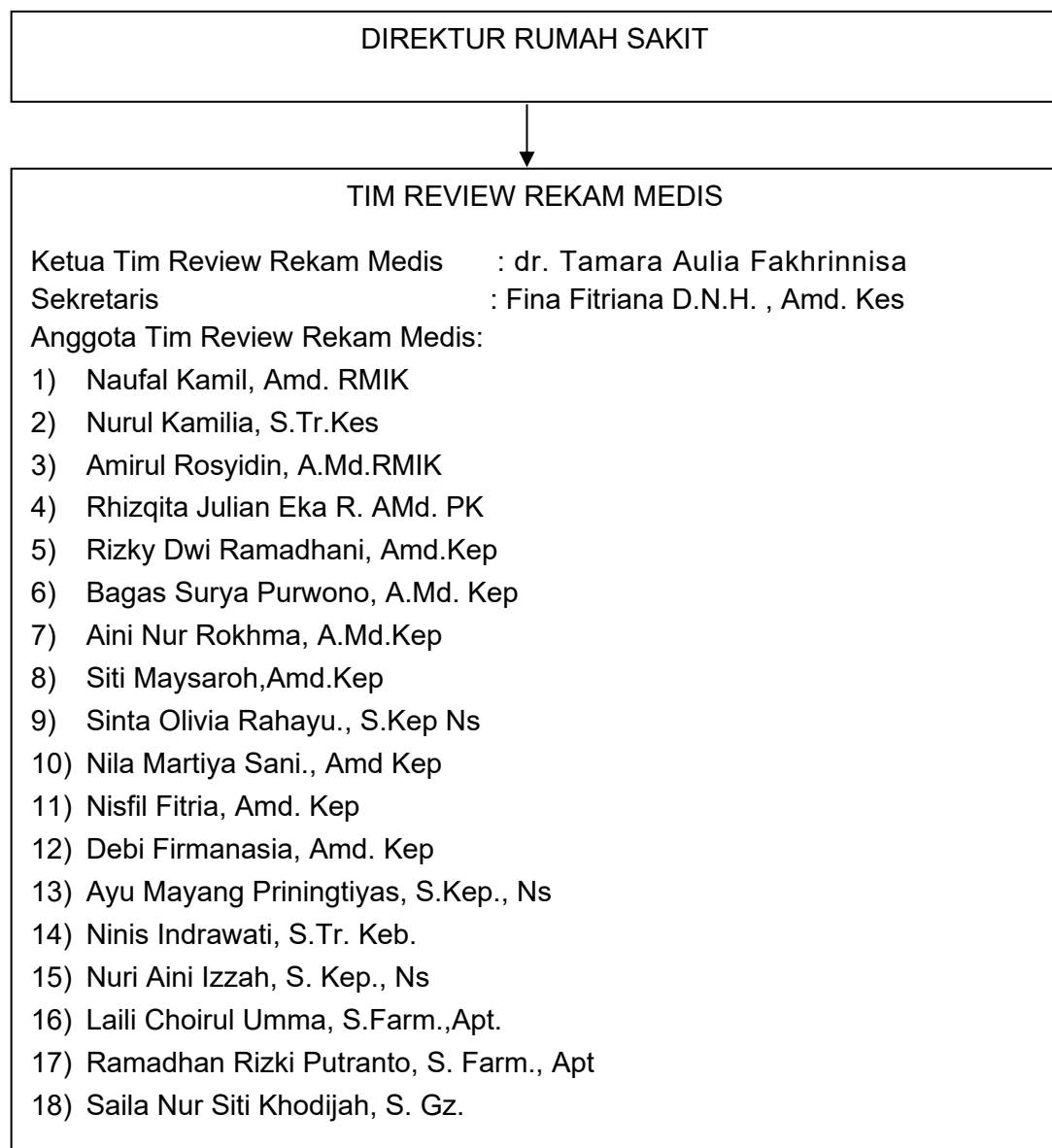
- 1) Tim review rekam medis ditetapkan oleh direktur rumah sakit prima husada
- 2) Pedoman kerja dan program kerja untuk melaksanakan review rekam medis ditetapkan oleh direktur rumah sakit prima husada
- 3) Review rekam medis menggunakan sampel yang mewakili dengan menggunakan rumus sampel dari slovin yaitu
$$n = \frac{1N}{1+N(d)^2} = \frac{1700}{1+1700(0.1)^2} = \frac{1700}{1+17} = \frac{1700}{18} = 94 \text{ sampel}$$

n : jumlah sampel
N : total populasi
d²: toleransi eror (0,1, dikarenakan populasi tidak sampai 1000)
- 4) Berdasarkan rumus sampel yang digunakan diatas terdapat besaran sampel yang harus dilakukan yaitu 94 sampel, dikarenakan kondisi rumah sakit masih baru maka untuk pengambilan sampel digunakan menurut metode sampling populasi
- 5) Proses review termasuk isi rekam medis sesuai dengan perundang-undangan

BAB III PENGORGANISASIAN

3.1 Struktur Organisasi

Organisasi Tim Review Rekam Medis disusun agar dapat mencapai visi, misi, dan tujuan dari penyelenggaraan rekam medis. Tim Review Rekam Medis dibentuk berdasarkan organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi dan dapat menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Efektif dimaksud agar sumber daya yang ada di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal.



3.2 Persyaratan Jabatan, Uraian Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang sebagai berikut:

1. Ketua Tim Review Rekam Medis

a. Persyaratan Jabatan

a) Pendidikan :

- a) S1 Pendidikan Dokter
- b) Memiliki STR dan SIP dokter yang masih berlaku
- c) Sumpah dokter

b) Pengetahuan dan Keterampilan :

- a) Memiliki pengetahuan di bidang rekam medis

- b) Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi rekam medis
- c) Pengalaman:
 - a) Memiliki pengalaman kerja yang relevan
- b. Uraian Tugas :
 - 1) Memimpin pelaksanaan kegiatan revidu atau audit rekam medis di rumah sakit.
 - 2) Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan revidu rekam medis.
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan revidu rekam medis dengan anggota tim.
 - 4) Mengawasi pelaksanaan revidu rekam medis agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Melakukan evaluasi terhadap hasil revidu rekam medis.
 - 6) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil revidu kepada pimpinan rumah sakit.
 - 7) Mengkoordinasikan tindak lanjut atas hasil revidu rekam medis dengan unit terkait.
- c. Tanggung Jawab :
 - 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan revidu rekam medis.
 - 2) Menjamin pelaksanaan revidu rekam medis berjalan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan.
 - 3) Menjamin kerahasiaan data dan informasi dalam rekam medis.
 - 4) Melaporkan hasil kegiatan revidu rekam medis kepada pimpinan rumah sakit.
- d. Wewenang :
 - 1) Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan anggota tim revidu rekam medis.
 - 2) Meminta data atau dokumen rekam medis yang diperlukan dalam proses revidu.
 - 3) Memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan rumah sakit terkait pengelolaan rekam medis.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan unit pelayanan, komite medis, dan unit terkait lainnya.

2. Sekretaris Tim Review Rekam Medis

a. Persyaratan Jabatan

- 1) Pendidikan:
 - a) Minimal D3 / D4 / S1 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK)
 - b) Memiliki STR Perekam Medis yang masih berlaku
 - c) Sumpah profesi Perekam Medis
- 2) Pengetahuan dan Keterampilan:
 - a) Memiliki pengetahuan mendalam di bidang manajemen informasi kesehatan dan regulasi rekam medis
 - b) Memiliki keterampilan dalam pengelolaan administrasi, korespondensi, pengolahan data statistik (KLPCM), dan dokumentasi kegiatan
- 3) **Pengalaman:**
 - a) Memiliki pengalaman kerja yang relevan di unit kerja rekam medis rumah sakit

b. Uraian Tugas:

- 1) Mengelola seluruh administrasi, surat-menyurat, dan pengarsipan dokumen kegiatan Tim Review Rekam Medis.
- 2) Membantu Ketua Tim dalam menyusun rencana kerja, jadwal pelaksanaan, serta menyiapkan instrumen/formulir revidu rekam medis.
- 3) Menyiapkan dan mendistribusikan berkas sampel rekam medis yang akan diperiksa oleh anggota tim reviewer.

- 4) Mencatat, merangkum, dan menyusun notulen dalam setiap rapat atau forum diskusi Tim Review Rekam Medis.
- 5) Melakukan kompilasi, rekapitulasi, dan pengolahan data hasil revidu dari seluruh anggota tim menjadi satu basis data.
- 6) Membantu Ketua Tim dalam menyusun draf laporan berkala hasil revidu rekam medis untuk disampaikan kepada pimpinan rumah sakit.
- 7) Mendokumentasikan bukti tindak lanjut dan umpan balik atas hasil revidu yang telah dikoordinasikan dengan unit terkait.

c. Tanggung Jawab:

- 1) Bertanggung jawab atas ketertiban, kerapian, dan keamanan seluruh arsip administrasi Tim Review Rekam Medis.
- 2) Menjamin keakuratan data rekapitulasi hasil revidu (seperti angka ketidaklengkapan/KLPCM) sebelum dilaporkan.
- 3) Menjamin kerahasiaan data pasien, berkas rekam medis, serta kerahasiaan dokumen internal hasil revidu tim.
- 4) Bertanggung jawab kepada Ketua Tim atas kesiapan fasilitas dan akomodasi pelaksanaan kegiatan revidu.

d. Wewenang:

- 1) Mengatur jadwal pertemuan, membagikan undangan rapat, dan memfasilitasi komunikasi antar-anggota tim revidu.
- 2) Meminta lembar hasil penilaian atau lembar kerja revidu yang telah diisi oleh masing-masing anggota reviewer untuk direkap.
- 3) Mengakses sistem informasi rumah sakit atau meminjam berkas rekam medis yang menjadi sampel revidu atas persetujuan Ketua Tim.
- 4) Menyerahkan draf rekapitulasi kendala dan ketidaklengkapan berkas kepada Ketua Tim untuk ditindaklanjuti.

3. Anggota Panitia Rekam Medis

a. Persyaratan Jabatan

- 1) Pendidikan :
 - a) Staf Medis : S1-Pendidikan Dokter
 - b) Staf Keperawatan : D3/S1 Keperawatan
 - c) Staf Klinis Lain : D3/S1 Kebidanan; S1 Farmasi; D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; D3/S1 Ahli Gizi
- 2) Pengetahuan dan Keterampilan:
 - a) Memiliki pengetahuan di bidang rekam medis
 - b) Memiliki keterampilan dalam perencanaan, penggerak, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi rekam medis
- 3) Pengalaman:
 - a) Pengalaman kerja minimal 2 tahun

b. Uraian Tugas :

- 1) Melaksanakan revidu atau audit rekam medis sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan penilaian terhadap kelengkapan, keterbacaan, dan ketepatan waktu pengisian rekam medis.
- 3) Mengidentifikasi permasalahan dalam pengisian dan pengelolaan rekam medis.
- 4) Mencatat dan mendokumentasikan hasil revidu rekam medis.
- 5) Memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan kepada ketua tim.
- 6) Membantu penyusunan laporan hasil revidu rekam medis.

c. Tanggung Jawab :

- 1) Melaksanakan kegiatan revidi rekam medis secara objektif dan profesional.
- 2) Menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam rekam medis.
- 3) Melaksanakan tugas sesuai arahan ketua tim.
- 4) Mendukung pelaksanaan peningkatan mutu pengelolaan rekam medis di rumah sakit.

d. Wewenang :

- 1) Mengakses dokumen rekam medis yang diperlukan untuk kegiatan revidi sesuai kewenangan.
- 2) Meminta klarifikasi kepada tenaga kesehatan terkait pengisian rekam medis.
- 3) Menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi kepada ketua tim.

BAB IV SARANA DAN FASILITAS

4.1 Sarana

Fasilitas fisik dan peralatan yang wajib disediakan untuk mendukung kerja harian tim meliputi:

1. Ruang Sekretariat: Akses penuh waktu (*full time*) untuk menunjang fokus dan kerahasiaan data pasien.
2. Perangkat Keras & Jaringan: Komputer, printer, dan koneksi internet stabil untuk pengolahan laporan digital.
3. Alat Komunikasi: Telepon kabel atau perangkat komunikasi khusus guna koordinasi antar-unit.
4. Logistik Kantor: Alat Tulis Kantor (ATK) lengkap untuk kebutuhan administrasi fisik.

4.2 Dukungan Manajemen

Bentuk komitmen dan akuntabilitas dari jajaran manajemen rumah sakit atau fasyankes, yang terbagi menjadi dua aspek utama:

1. Dukungan Legalitas
 - a. Penerbitan Surat Keputusan (SK) resmi untuk memberikan wewenang dan dasar hukum yang sah bagi Tim Review Rekam Medis.
2. Dukungan Finansial & Anggaran
 - a. Pendidikan & Pelatihan: Dana khusus untuk Diklat guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota tim.
 - b. Fasilitas Penunjang: Alokasi anggaran pengadaan serta perawatan alat-alat pelayanan yang mendukung manajemen rekam medis.
 - c. Operasional Program: Ketersediaan dana pelaksanaan program kerja, proses monitoring, evaluasi berkala, penyusunan laporan, hingga penyelenggaraan rapat rutin.
 - d. Apresiasi SDM: Pemberian insentif, tunjangan, atau sistem *reward* (penghargaan) bagi anggota tim atas capaian kinerjanya.

BAB V TATA LAKSANA

Kegiatan Tim Review Rekam Medis di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya merupakan suatu standar mutu pelayanan yang bersifat mandatori. Monitoring ini sangat penting bagi pasien (menjamin hak informasi klinis), petugas kesehatan (melindungi aspek legal asuhan), maupun manajemen rumah sakit (dasar pengambilan keputusan tata kelola klinis).

Pelayanan ini wajib dilaksanakan secara berkala oleh Tim Review Rekam Medis untuk menilai keakuratan, keabsahan, dan relevansi isi dari rekam medis yang telah diisi oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) terkait.

Untuk memastikan kegiatan operasional berjalan secara konsisten, objektif, dan terukur, penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada wajib memenuhi 5 (lima) kriteria pendukung sebagai berikut:

- 1) Pedoman Kerja Tertulis: Tersedianya dokumen Pedoman Kerja Tim Review Rekam Medis yang disahkan oleh Direktur sebagai acuan legal, baku, dan mengikat bagi seluruh staf klinis dan non-klinis di rumah sakit.
- 2) Cakupan Kegiatan Terprogram: Adanya cakupan kegiatan tertulis mengenai program review rekam medis yang wajib dimonitor dan dievaluasi setiap periode, yang memuat 3 (tiga) pilar kualitas utama:
 - a) Ketepatan Waktu (*Timeliness*): Kepatuhan waktu pengisian dan pengembalian dokumen rekam medis (terutama ringkasan pulang/discharge summary) maksimal 1 x 24 jam setelah pasien keluar.
 - b) Keterbacaan (*Legibility*): Kejelasan tulisan tangan staf klinis, instruksi medis, dan validitas input data pada sistem Rekam Medis Elektronik (RME) demi mencegah kesalahan penafsiran klinis.
 - c) Kelengkapan (*Completeness*): Pemenuhan seluruh komponen wajib rekam medis mulai dari identitas pasien, laporan asuhan, hasil penunjang, hingga autentikasi (nama dan tanda tangan PPA).
- 3) Metode Sampling Berbasis Regulasi Mutu: Penggunaan sampel review rekam medis mengacu pada prinsip statistik. Dikarenakan kondisi Rumah Sakit Prima Husada masih berstatus baru, maka untuk menjaga akurasi evaluasi awal, penentuan sampel menggunakan Metode Sampling Semua Populasi (Total Sampling / Sampling Jenuh), di mana seluruh dokumen rekam medis pasien keluar pada periode audit ditinjau secara menyeluruh tanpa pengurangan sampel.
- 4) Siklus Evaluasi dan Tindak Lanjut Berkala: Pelaksanaan program kerja Tim Review Rekam Medis wajib dievaluasi melalui rapat pleno berkala. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti secara nyata, pemberian umpan balik kepada Unit terkait, serta koordinasi bersama Komite Medik untuk perbaikan mutu asuhan secara kontinu.
- 5) Penyempurnaan Kebijakan Berkala: Kebijakan, pedoman kerja, dan standar operasional prosedur terkait Tim Review Rekam Medis wajib dilakukan evaluasi dan telaah ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disempurnakan. Evaluasi ini dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kesehatan (terutama penguatan sistem RME), dinamika operasional internal rumah sakit, serta perubahan peraturan perundangan-undangan nasional yang berlaku.

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

6.1 Pencatatan dan pelaporan

- a. Setiap anggota Tim Review Rekam Medis wajib mencatat hasil review berkas rekam medis secara berkala menggunakan formulir review yang berlaku (manual atau elektronik).
- b. Data hasil review dikumpulkan, direkapitulasi, dan dianalisis oleh sekretaris atau penanggung jawab data tim setiap bulan.
- c. Tim Review Rekam Medis wajib menyusun dan menyerahkan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan) kepada Direktur Rumah Sakit.
- d. Laporan tertulis tersebut minimal memuat:
 - 1) Cakupan jumlah sampel rekam medis yang direview.
 - 2) Angka Kelengkapan Pengisian Catatan Medis (KLPCM).
 - 3) Angka Ketepatan Waktu Pengembalian Berkas Rekam Medis.
 - 4) Analisis masalah, hambatan, serta rekomendasi perbaikan mutu rekam medis.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

7.1. Monitoring

1. Monitoring terhadap kepatuhan pengisian dan pengembalian rekam medis dilakukan secara berkelanjutan secara internal di unit masing-masing.
2. Proses monitoring ini dilaksanakan secara aktif oleh seluruh anggota Tim Review Rekam Medis sesuai dengan pembagian tugas dan area pelayanan (Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Gawat Darurat).
3. Hasil monitoring harian/mingguan digunakan sebagai instrumen kendali mutu sebelum data direkapitulasi menjadi laporan bulanan.

7.2. Evaluasi

1. Evaluasi berkala terhadap hasil review rekam medis wajib dilakukan oleh seluruh anggota Tim Review Rekam Medis minimal 1 (satu) bulan sekali melalui rapat koordinasi internal.
2. Agenda evaluasi bulanan meliputi:
 - a. Penilaian kesenjangan (*gap analysis*) antara target mutu rekam medis dengan realisasi di lapangan.
 - b. Identifikasi faktor penyebab ketidaklengkapan berkas (kendala DPJP, perawat, atau sistem SIMRS/EMR).
 - c. Perumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret untuk perbaikan bulan berikutnya.
3. Hasil evaluasi bulanan ini menjadi bahan dasar utama dalam penyusunan laporan tertulis triwulanan yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 17 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep